

Nome: JOSÉ CIVIDANES
Data de Nascimento: 4-9-1945
IMC: 24,54
Sexo: Masculino
Data do exame: 30-09-2024

Peso: 76 kg
Altura: 1,76 m
Médico: DR. BRUNO NOGUEIRA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 30-09-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 453,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 8,0 e 223,0 minutos. O tempo total de sono foi de 221,5 min, eficiência de 48,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,8%; estágio N2: 71,6%; estágio N3: 9,7%; sono REM: 14,9%. O índice de despertares foi de 21,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 50,9/hora, sendo 1 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 185 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 89%, permanecendo 0,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 53 - 71 bpm e NREM de 53 - 73 bpm.

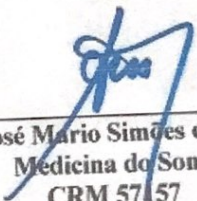
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (7), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 50,9/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=89%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Apresentado ao Rodrigo, em 3/11/24